Hamilton Rating Scale for Depression (HAM-D)

42

Purpose One of the most frequently used instruments for evaluating depression in adults, the questionnaire allows clinicians to assess the nature and severity of mood disorders in patient populations. The scale is comprised of 21 items for inquiry, though only the first 17 are used in scoring. Each question examines a different symptom or aspect of depression, including: mood, guilty feelings, suicidal ideation, insomnia, agitation, and somatic symptoms. The scale is suitable for use in a variety of research and clinical settings, and can be applied as both a single-use instrument for measuring depression severity and as a tool for monitoring changes in depressive symptoms over the course of treatment. Items 4, 5, and 6 refer specifically to sleep, inquiring about insomnia prior to sleep onset, disturbed sleep in the middle of the night, and trouble falling back sleep in the early morning, respectively. Other items may be peripherally involved with sleep difficulties as they refer to fatigue, retardation, and somatic symptoms in general. It should be noted that there have been different iterations with longer, shorter, and one version with specific modifications for seasonal affective disorder [10].

Population for Testing The scale has been validated across a variety of studies, primarily in adult populations possessing major depressive disorder.

Administration The scale is administered through an interview conducted by a trained clinician. Its administration time will vary depending on the specific needs of the patient and the interviewer's preferred approach. On average, it should require approximately 10–15 min. Some have expressed concern regarding the interpretive nature of the instrument. The scale requires a trained clinician capable of distilling information regarding both frequency and intensity of symptoms into a single score, potentially making it inefficient for use in large research projects. To address this, a number of researchers (including Potts and colleagues [1]) have designed structured-interview versions of the HAM-D which can be administered in a variety of settings by interviewers without backgrounds in psychiatry. For even greater ease of use, a self-report, paper-and-pencil version is also available – the Hamilton Depression Inventory developed by Reynolds and Kobak [2]. Additional alternative versions include tests with fewer items and questionnaires with modified rating scales.

Reliability and Validity The psychometric properties of the HAM-D have been examined in a wide array of studies since its creation by Hamilton in 1960 [3]. One of the most recent reviews conducted by Bagby and colleagues [4] evaluated psychometric properties reported in 70 different articles, finding an internal reliability ranging from .46 to .97, an inter-rater reliability of .82 to .98, and a test–retest reliability of .81 to .98. Though scores for the scale as a whole appear to be quite high, studies examining inter-rater reliabilities and

A. Shahid et al. (eds.), *STOP, THAT and One Hundred Other Sleep Scales,*
DOI 10.1007/978-1-4419-9893-4_42, © Springer Science+Business Media, LLC 2012

test–retest coefficients at the level of individual items have found values that are much lower. Others have criticized the scale as outdated in terms of the DSM-IV definition of depression and have claimed that its scoring is unclear. Overall, the HAM-D's tremendous staying power has made it the subject of studies both laudatory and critical in nature [5, 6]. Decisions regarding its psychometric suitability should be undertaken carefully and on a case-by-case basis. For one of Hamilton's final writings on the subject of depression and the selection of depression scales, turn to a review written by Hamilton and Shapiro in *Measuring Human Problems: A Practical Guide* [7].

Obtaining a Copy A copy of the original scale can be found in Hamilton [3]. A large number of modified versions are available from their respective designers.

Scoring Though all 21 items may be valuable for both research and clinical purposes, only the first 17 are used for scoring. During the interview, clinicians solicit patient reports on a variety of depressive symptoms and use their clinical expertise to assign each a score for severity. For the majority of questions, scores range from 0 to 4, with 4 representing more acute signs of depression. Several questions have ranges that extend only as high as 2 or 3. A total score is tallied and can then be compared with previous scores or can be contrasted with a pre-defined cutoff score. Over the decades, a number of values have been suggested as potential cutoffs – total scores to be used as indicators of remission. Though the cutoff of 7 suggested by Frank and colleagues [8] has become a consensus for determining remission, others suggest that it should be as low as 2 [9].

Hamilton Depression Rating Scale (HDRS)

PLEASE COMPLETE THE SCALE BASED ON A STRUCTURED INTERVIEW

Instructions: for each item select the one "cue" which best characterizes the patient. Be sure to record the answers in the appropriate spaces (positions 0 through 4).

1 **DEPRESSED MOOD** *(sadness, hopeless, helpless, worthless)*
- 0 |__| Absent.
- 1 |__| These feeling states indicated only on questioning.
- 2 |__| These feeling states spontaneously reported verbally.
- 3 |__| Communicates feeling states non-verbally, i.e. through facial expression, posture, voice and tendency to weep.
- 4 |__| Patient reports virtually only these feeling states in his/her spontaneous verbal and non-verbal communication.

2 **FEELINGS OF GUILT**
- 0 |__| Absent.
- 1 |__| Self reproach, feels he/she has let people down.
- 2 |__| Ideas of guilt or rumination over past errors or sinful deeds.
- 3 |__| Present illness is a punishment. Delusions of guilt.
- 4 |__| Hears accusatory or denunciatory voices and/or experiences threatening visual hallucinations.

3 **SUICIDE**
- 0 |__| Absent.
- 1 |__| Feels life is not worth living.
- 2 |__| Wishes he/she were dead or any thoughts of possible death to self.
- 3 |__| Ideas or gestures of suicide.
- 4 |__| Attempts at suicide (any serious attempt rate 4).

4 **INSOMNIA: EARLY IN THE NIGHT**
- 0 |__| No difficulty falling asleep.
- 1 |__| Complains of occasional difficulty falling asleep, i.e. more than ½ hour.
- 2 |__| Complains of nightly difficulty falling asleep.

5 **INSOMNIA: MIDDLE OF THE NIGHT**
- 0 |__| No difficulty.
- 1 |__| Patient complains of being restless and disturbed during the night.
- 2 |__| Waking during the night – any getting out of bed rates 2 (except for purposes of voiding).

11 **ANXIETY SOMATIC (physiological concomitants of anxiety) such as:**
gastro-intestinal – dry mouth, wind, indigestion, diarrhea, cramps, belching
cardio-vascular – palpitations, headaches
respiratory – hyperventilation, sighing
urinary frequency
sweating
- 0 |__| Absent.
- 1 |__| Mild.
- 2 |__| Moderate.
- 3 |__| Severe.
- 4 |__| Incapacitating.

12 **SOMATIC SYMPTOMS GASTRO-INTESTINAL**
- 0 |__| None.
- 1 |__| Loss of appetite but eating without staff encouragement. Heavy feelings in abdomen.
- 2 |__| Difficulty eating without staff urging. Requests or requires laxatives or medication for bowels or medication for gastro-intestinal symptoms.

6 INSOMNIA: EARLY HOURS OF THE MORNING
- 0 |__| No difficulty.
- 1 |__| Waking in early hours of the morning but goes back to sleep.
- 2 |__| Unable to fall asleep again if he/she gets out of bed.

7 WORK AND ACTIVITIES
- 0 |__| No difficulty.
- 1 |__| Thoughts and feelings of incapacity, fatigue or weakness related to activities, work or hobbies.
- 2 |__| Loss of interest in activity, hobbies or work – either directly reported by the patient or indirect in listlessness, indecision and vacillation (feels he/she has to push self to work or activities).
- 3 |__| Decrease in actual time spent in activities or decrease in productivity. Rate 3 if the patient does not spend at least three hours a day in activities (job or hobbies) excluding routine chores.
- 4 |__| Stopped working because of present illness. Rate 4 if patient engages in no activities except routine chores, or if patient fails to perform routine chores unassisted.

8 RETARDATION (slowness of thought and speech, impaired ability to concentrate, decreased motor activity)
- 0 |__| Normal speech and thought.
- 1 |__| Slight retardation during the interview.
- 2 |__| Obvious retardation during the interview.
- 3 |__| Interview difficult.
- 4 |__| Complete stupor.

9 AGITATION
- 0 |__| None.
- 1 |__| Fidgetiness.
- 2 |__| Playing with hands, hair, etc.
- 3 |__| Moving about, can't sit still.
- 4 |__| Hand wringing, nail biting, hair-pulling, biting of lips.

10 ANXIETY PSYCHIC
- 0 |__| No difficulty.
- 1 |__| Subjective tension and irritability.
- 2 |__| Worrying about minor matters.
- 3 |__| Apprehensive attitude apparent in face or speech.
- 4 |__| Fears expressed without questioning.

13 GENERAL SOMATIC SYMPTOMS
- 0 |__| None.
- 1 |__| Heaviness in limbs, back or head. Backaches, headaches, muscle aches. Loss of energy and fatigability.
- 2 |__| Any clear-cut symptom rates 2.

14 GENITAL SYMPTOMS (symptoms such as loss of libido, menstrual disturbances)
- 0 |__| Absent.
- 1 |__| Mild.
- 2 |__| Severe.

15 HYPOCHONDRIASIS
- 0 |__| Not present.
- 1 |__| Self-absorption (bodily).
- 2 |__| Preoccupation with health.
- 3 |__| Frequent complaints, requests for help, etc.
- 4 |__| Hypochondriacal delusions.

16 LOSS OF WEIGHT *(RATE EITHER a OR b)*

a) According to the patient:	b) According to weekly measurements:
0 |__| No weight loss.	0 |__| Less than 1 lb weight loss in week.
1 |__| Probable weight loss associated with present illness.	1 |__| Greater than 1 lb weight loss in week.
2 |__| Definite (according to patient) weight loss.	2 |__| Greater than 2 lb weight loss in week.
3 |__| Not assessed.	3 |__| Not assessed.

17 INSIGHT
- 0 |__| Acknowledges being depressed and ill.
- 1 |__| Acknowledges illness but attributes cause to bad food, climate, overwork, virus, need for rest, etc.
- 2 |__| Denies being ill at all.

Total score: |__|__|

This scale is in the public domain.

References

1. Potts, M. K., Daniels, M., Burnam, M. A., & Wells, K. B. (1991). A structured interview version of the Hamilton Depression Rating Scale: evidence of reliability and versatility of administration.
2. Reynolds, W. M., & Kobak, K. A. (1995). *Hamilton Depression Inventory*. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.
3. Hamilton, M. (1960). A rating scale for depression. *Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry, 23*, 56–62.
4. Bagby, R. M., Ryder, A. G., Schuller, D. R., & Marshall, M. B. (2004) The Hamilton Depression Rating Scale: has the gold standard become a lead weight? *American Journal of Psychiatry, 161*(12), 2163–2177.
5. Hedlund, J. L., & Vieweg, B. W. (1979). The Hamilton Rating Scale for Depression: a comprehensive review. *Journal of Operational Psychiatry, 10*, 149–165.
6. Knesevich, J. W., Biggs, J. T., Clayton, P. J., & Ziegler, V. E. (1977). Validity of the Hamilton Rating Scale for Depression. *The British Journal of Psychiatry, 131*, 49–52.
7. Hamilton, M., & Shaprio, C. M. (1990). Depression. In D. F. Peck & C. M. Shapiro (Eds.), *Measuring Human Problems* (25–65). Great Britain: John Wiley & Sons.
8. Frank, E., Prien, R. F., Jarrett, R. B., Keller, M. B., Kupfer, D. J., Lavori, P. W., Rush, A. J., & Weissman, M. M. (1991). Conceptualization and rationale for consensus definitions of terms in major depressive disorder: remission, recovery, relapse, and recurrence. *Archives of General Psychiatry, 48*(9), 851–855.

9. Zimmerman, M., Posternak, M. A., & Chelminski, I. (2005). Is the cutoff to define remission on the Hamilton Rating Scale for Depression too high? *The Journal of Nervous and Mental Disease, 193*(3), 170–175.
10. Williams, J. B. W., Link, M. J., Rosenthal, N. E., Terman, M. (1998). Structured Interview Guide for the Hamilton Depression Rating Scale, Seasonal Affective Disorders Version (SIGHSAD). New York Psychiatric Institute, New York.

Representative Studies Using Scale

Reynolds, C. F., Dew, M. A., Pollock, B. G., Mulsant, B. H., Frank, E., Miller, M. D., Houck, P. R., Mazumdar, S., Butters, M. A., Stack, J. A., Schlernitzauer, M. A., Whyte, E. M., Gildengers, A., Karp, J., Lenze, E., Szanto, K., Bensasi, S., & Kupfer, D. J. (2006). Maintenance treatment of major depression in old age. *New England Journal of Medicine, 354*(11), 1130–1138.

Brecht, S., Kajdasz, D., Ball, S., & Thase, M. E. (2008). Clinical impact of duloxetine treatment on sleep in patients with major depressive disorder. *International Clinical Psychopharmacology, 23*(6), 317–324.

Levitan, R., Shen, J., Jindal, J., Driver, H. S., Kennedy, S. H., & Shapiro, C. M. (2000). A preliminary randomized double-blind placebo controlled trial of tryptophan combined with fluoxetine in the treatment of major depression: anti-depressant and hypnotic effects. *Journal of Psychiatry & Neuroscience, 25*, 337–346.

核心課程編號：B17

憂鬱

神經科部

學習目標

PGY	UGY
知識 1.憂鬱症與其他精神病的共病現象 2.憂鬱症與其他精神病鑑別診斷 3.憂鬱症的認知理論 4. 憂鬱症的治療與處置 5. 自殺防治及強制住院相關法令與通報	**知識** 1. 憂鬱症的症狀、徵候和病因 2. 憂鬱症的診斷標準、次分類 3. 憂鬱症的流行病學 4. 憂鬱症的生物心理社會因素 5. 憂鬱症治療的原則（含藥物和心理治療） 6. 抗憂鬱藥的機轉和副作用 7. 會診精神科的時機 8. 強制住院相關的法令與通報 **技能** 1. 憂鬱症相關的病史詢問 2. 憂鬱症相關的精神狀態檢查及描述精神病理 3. 評估自殺的危險性 4. 促進病人順從醫囑

ITE考題

三 軍 總 醫 院 一 般 醫 學 訓 練

In-Training Exam-憂鬱 Depression (B17)

陳女士、65 歲、罹患糖尿病右足壞疽，醫療團隊建議截肢手術，兩個月前丈夫過世、情緒低落、睡眠障礙、對周遭失去興趣、食慾及活力減低、注意力下降、影響社交活動。

1. 簡述憂鬱症分類與診斷條件 [20分]
2. 憂鬱症與其他疾病共病現象 [15分]
3. 憂鬱症的鑑別診斷(三個) [15分]
4. 簡述憂鬱症的治療與處置 [25分]
5. 簡述自殺防治及強制住院相關法令與通報 [25分]

憂鬱症的病因1

- 憂鬱症的病因複雜，牽涉到多項生物學、心理學與社會學的相互機制，「多變因的模式」是最好的解釋方式。
- 影響憂鬱症的主要兩大神經系統，主要是大腦情緒中樞的單胺系統及下視丘-腦下垂體-腎上腺皮質(HPA)系統。 憂鬱症患者的HPA系統的活性過高，使得患者對cortisol抑制回饋作用不足；另外，憂鬱症患者下視丘的過度分泌CRF，促進腦下垂體分泌腎上腺皮質刺激素，也可能是產生焦慮、性慾降低、食慾降低及睡眠障礙的原因。

憂鬱症的病因2

- 精神藥理學有關憂鬱症相關的中樞神經傳導物質的研究報告，如serotonin及norepinephrine，包括其合成與代謝的過程以及相關機制的控管，神經傳導物質傳遞過程中與接受體的作用機轉等。
- serotonin 在神經元突觸間隙(synaptic cleft)的作用，需依賴載具(serotonin transporter)的執行，而載具的蛋白結構及其調控基因，也成為目前憂鬱症基因的熱門研究重點。

憂鬱症的病因3

- 藥物也可能引起憂鬱症，如抗高血壓藥物、抗癌藥及類固醇等藥物均可能產生憂鬱症；身體荷爾蒙分泌異常也可能引起憂鬱症，例如甲狀腺功能低下。而月經前、產後及停經後婦女，也常有憂鬱症。
- 腦部受傷、中風（腦血管栓塞或出血）或腦瘤也可能引起憂鬱症。
- 先有所謂脆弱的體質，加上後天的條件上，包括藥物及其他物質的濫用，或個人對於生活重大壓力事件的調適困難，如孤獨、失業、貧窮、慢性身體疾病等因素的壓力下，憂鬱症就發生。

憂鬱症的症狀、徵候

1. 胃口變差、食慾減退或增加、體重明顯減輕或增加、失眠或嗜睡、幾乎整天都極度疲勞與缺乏能量、精神或動作反應激動或遲滯、性慾降低、頭痛、頭昏、眼睛疲勞、眼角酸痛、口渴、頸部酸痛、胸悶、呼吸不暢、胸痛、腹脹、頻尿、身體酸痛、腰酸痛、盜汗與便秘感或一天數次大便等。
2. 憂鬱、心情沮喪或掉到谷底、無望、易流淚、悲傷、激動易怒、害怕與恐懼、寂寞、無聊、感情淡薄、對自己不滿意、滿足感減少、興趣明顯減退、失去幽默感、低估自己能力、悲觀、自我譴責（常感到罪惡感或無價值感）、低自尊、容易感到挫折、社交退縮、時常健忘、思考、注意、決斷力減退或猶豫不決、意志喪失、作業效率或生產力皆減少、自殺意念及行為、胸部沈重苦悶與強迫回想舊事等。

憂鬱症的症狀、徵候

3.可能是孩童與青少年期常見的改變症狀：

功課突然退步、突然開始坐立不安、身體動作突然變慢、講話音調變單調或變得沈默不語、無法解釋地情緒激躁、無法解釋地常常哭泣、常常顯得很害怕或緊張、突然變得有攻擊性、有反社會行為、開始使用酒精或其它成癮性物質、不停地抱怨身體某部位疼痛不適，卻又找不到病因。

憂鬱症的心理因素1

- 人格與人格發展

  憂鬱發作與負面事件之間有直接聯繫，受個人的性格所影響、應對負面事件的方式可能與他們的憂鬱發作有關。低自尊心、自暴自棄或者歪曲的認識可能與憂鬱症有關。

- 哪些心理因素造成了憂鬱症或者對憂鬱症造成影響現在還不是完全清楚，但是糾正思維模式後患者的心境與自尊心都會改善。

憂鬱症的心理因素2

- 美國心理學家艾倫·貝克（Aaron T. Beck）於20世紀60年代初發展了現在被稱為憂鬱的**認知模式的理論**。他主張三個觀念引起了憂鬱症：一、認知三合一模式—關於自己，關於周圍世界，關於自己的未來的消極認知；二、反覆的消極認知模式或圖式；三、歪曲的信息處理。根據這理論，他發展了系統化的認知行為療法（CBT）。
- 根據美國心理學家馬汀·塞利格曼（Martin Seligman），人類的憂鬱症狀與實驗室動物的**習得性失助**類似。(就是「經過某事後學習得來的」無助感，意謂著一種被動的動物消極行為。)

憂鬱症的心理因素3

- **典型的憂鬱素質與悲觀主義**

  患者經常因為消極的事件而責怪自己；與之對應的是，1993年一項針對因憂鬱症住院的青少年的研究顯示即使事情有積極的結果他們也並不感到滿意。

- 根據加拿大心理-社會心理學家阿爾伯特·班杜拉（Albert Bandura）的**社會學習理論**：基於失敗的經歷、對失敗的社會模型的觀察、缺乏社會支持和他們自己的身體和情感狀態（包括緊張和壓力），憂鬱症患者對自己產生消極的認識。這造成了消極的自我概念和自我效能感的缺失，即患者不相信他們能對事物產生影響或者達成目標。

憂鬱症的心理因素4

- 一項女性憂鬱症的調查顯示，心理易感因素—例如早年喪失母親、缺乏值得信任的關係、負責照看更年幼的孩子及失業可以和生活緊張性刺激互相影響增加患憂鬱症的風險。
- 對於老年人，易感因素往往是健康問題、與子女或配偶轉換角色（由照顧者變為被照顧者）、重要夥伴的逝世、因朋友的健康問題所造成的社會關係改變等。

憂鬱症的心理因素5

- 憂鬱症本質的理論
- 根據奧地利精神病專家西格蒙德·弗洛伊德（Sigmund Freud）的經典精神分析理論，憂鬱症，或精神憂鬱症可能與人際關係喪失和早年經歷有關。
- 存在主義理論心理學家則把憂鬱症與現時存在意義和未來願景的缺失相聯繫。存在主義心理學的奠基人—美國心理學家亞伯拉罕·馬斯洛（Abraham Maslow）則認為當人們無法滿足需求或者自我實現以認識到自己的潛力時，憂鬱症可能發作。

憂鬱症的生物因素1

❖單胺假說

研究人員發現，大多數已知的抗憂鬱藥會增加一種或多種單胺類神經遞質在腦內的水平。單胺類神經遞質包括：5-HT、NE和Dopamine。抗憂鬱藥會提高這些物質在大腦神經元之間（突觸）的水平或直接影響神經元之間的感受器。

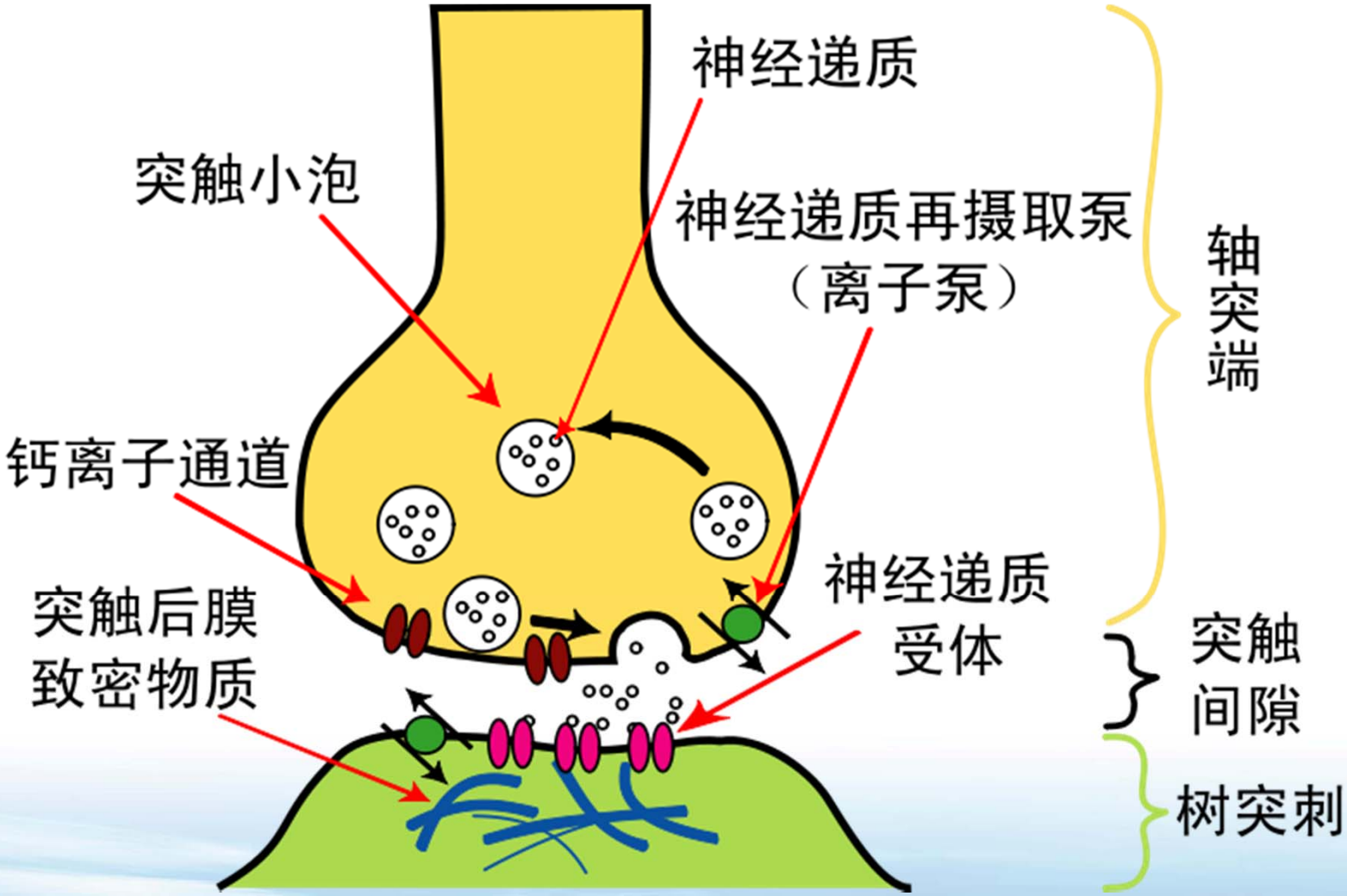
憂鬱症的生物因素2

- 允許性假說

  研究人員認為，在單胺類神經遞質中，5-HT被用來調節其他神經遞質系統，5-HT活性降低會導致這些系統處於失調狀態，因此當5-HT水平降低時，會造成NE水平降低，NE會使人產生憂鬱的感覺。

- 這種假說的支持者提出：患者應當針對最突出的徵狀選擇有特殊機理的抗憂鬱藥，即焦慮與暴躁的病人應該選擇選擇性5-羥色胺再攝取抑製劑（SSRIs）或者去甲腎上腺素再攝取抑製劑（NRIs），感到能量喪失和生活無趣的病人應選擇能提高Dopamine和NE水平的藥物。

憂鬱症的生物因素3



憂鬱症的社會因素

- 貧窮和社會孤立通常會提高患精神問題的風險。
- 兒時遭受虐待（身體、情感、性或者被忽視）會提高今後患憂鬱障礙的風險
- 家庭功能受損，例如父母（尤其是母親）患憂鬱症、嚴重的夫妻衝突或離婚、失去雙親或者其他使家庭功能受損的情況都是患病的風險因素。在成年以後，生活應激事件與重性憂鬱發作有很強的聯繫。尤其第一次發作比複發更容易由生活應激事件引發。
- 缺乏社會支持造成了應激事件增加進而引發憂鬱症，或者是社會支持的缺乏直接引發憂鬱症，生活應激事件與社會支持之間的關係尚有爭議。犯罪或違禁藥物造成的不和諧的鄰里關係是發病的危險因素，而融洽宜人的鄰里關係則是防止憂鬱症的保護因素。儘管各種各樣的因素交錯混雜，但是惡劣的工作條件，特別是費力且只有很少的自主決定權的工作，可能與憂鬱症有關。

憂鬱症的流行病學1

- 憂鬱症的異質性很高，關於憂鬱症盛行率的統計，各地區不一。世界衛生組織預估的盛行率是總人口數的3%，而美國衛生研究院的報告指出，一般人口中，憂鬱症的終生盛行率為15%。
- 憂鬱症的盛行率，女性比男性高約2倍，其原因包括社會經濟因素，如婦女相對的弱勢，有較高機會在孩童時期受到性侵害等以及受女性荷爾蒙的影響，如產後憂鬱症及更年期憂鬱症。一半的憂鬱症發病年齡在20~50歲。老年憂鬱症的盛行率不低，約為25~50%，但是容易被輕忽及低估。 老年憂鬱症通常與獨居、低社經階層及身體疾病相關。

憂鬱症的流行病學2

- 根據2010 年世界衛生組織進行的全球疾病負擔研究[註一]，以疾病導致失能而言，在所有疾病中，憂鬱症造成的失能人年數[註二]排在所有疾病的第二位；對照自1990 年開始的全球疾病負擔研究結果，肇因於憂鬱症的疾病負擔，從1990 年到2010 年大幅增加了37.5%[註三]。可見憂鬱症帶來的負擔，隨著時間愈來愈顯著，所以憂鬱症的治療和預防更是益發重要。

註一「全球疾病負擔研究」係Global Burden of Disease study。
註二「失能人年數」係years lived with disability，YLD。
註三 PLoS Med, 2013. 10(11): p. e1001547.

憂鬱症的流行病學3

- 台灣地區的重鬱症盛行率，由台大李明濱教授及陳為堅教授等人所主持的台灣精神疾病調查顯示，在2003 年到2005 年間，18 歲以上成年人符合重鬱症診斷標準者大約在1.2%左右，也就是將近有20 萬人罹患重鬱症[註一]。其實這是依照較嚴謹的標準，用來定義憂鬱症狀嚴重度較高的個案；所以，要是不管有沒有達到嚴格的診斷標準，在一般人口中，因憂鬱焦慮情緒而感到困擾的比例必定大幅提高。憂鬱不但影響生活品質，還可能造成一個最不願意見到的遺憾，那就是— 自殺。
- 根據研究顯示，自殺死亡的個案中，約九成在生前患有憂鬱症，反之，憂鬱症患者約15%最後會自殺死亡。

註一 Psychol Med, 2012.42(6): p. 1227-37.

憂鬱症的分類與診斷1

一、原發性憂鬱症：一般是指由以下三個原因所引發的憂鬱症 。

1. 與這些人的遺傳體質相關，雖然影響程度輕重有別。
2. 憂鬱型性格，先天就是有此鬱鬱寡歡的特質。別人認為快樂的一件事，對這些人而言，只出現短暫的歡愉，隨即又陷入苦悶的情緒。
3. 有明確的外界刺激或誘發因素，如親人的死亡等重大事件，這些事件通常來得太突然，且超出正常可忍受 的範圍。

憂鬱症的分類與診斷2

二、次發性憂鬱症：一般是指生理疾病導致的憂鬱症。

1. 腦部的疾病，如巴金森症、中風、腦瘤、痴呆症。
2. 內分泌疾病，如甲狀腺機能低下、腎上腺功能過高。
3. 惡性貧血。
4. 各種癌症患者
5. 藥物引起之憂鬱症
6. 其他生理疾病，如心臟病。

❖ 這樣的分類，目的是想釐清憂鬱症的病因，但上述的病因仍有相有交互作用，想清楚分界並不容易。

DSM-5憂鬱情緒精神科診斷

- 美國精神醫學會在2013 年5 月公佈最新版，也就是第五版精神疾病診斷與統計手冊（DSM-5），當中與憂鬱情緒相關的精神科診斷包括：重鬱症、持續性憂鬱症（或稱輕鬱情感障礙症）、適應障礙症，以及經前期情緒障礙症。

註一「第五版精神疾病診斷與統計手冊」係The Fifth Edition of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-5。
註二「重鬱症」係Major Depressive Disorder。
註三「持續性憂鬱症」係Persistent Depressive Disorder；輕鬱情感障礙症」係Dysthymia。
註四「適應障礙症」係Adjustment Disorders。
註五「經前期情緒障礙症」係Premenstrual Dysphoric Disorder。
註六「雙相情緒障礙症」或稱「躁鬱症」係Bipolar（Affective）Disorder。

DSM-5 重鬱症(I)

- 「重鬱症」診斷標準要求持續兩個星期，每天大部分時間內，出現至少五項與憂鬱情緒相關的特徵性症狀，並且必須包括(1)憂鬱情緒或(2)喪失興趣或愉悅感的其中一項，同時伴隨有功能上的顯著變化。
- (1)幾乎每天大多數時間都呈現憂鬱情緒；
- (2)幾乎每天大多數時間，對於全部（或幾乎全部）的活動都喪失興趣或無法從中感到愉悅；
- (3)顯著的體重減少或增加(如在一個月之內體重變化超過5%)或幾乎每天都有食慾減低或增加的現象；
- (4)幾乎每天都有失眠或嗜睡的現象；

DSM-5 重鬱症 (II)

- (5)幾乎每天都呈現精神運動性激動或遲滯；
- (6)幾乎每天都感到疲倦或沒有力氣
- (7)幾乎每天覺得自己沒有價值，或有過度或不合理的罪惡感
- (8)幾乎每天都感到思考或專注能力的下降，或變得猶豫不決
- (9)反覆出現輕生的念頭，或反覆出現沒有具體計劃的自
- 殺意念，或已出現自殺企圖或已有特定的自殺計劃。
- 個案因這些症狀而感到顯著痛苦，或是因此在社交、職業或其他重要領域的功能顯著下降。

DSM-5持續性憂鬱症 (I)

- 「持續性憂鬱症」的診斷標準和重鬱症略有不同，強調的是個案呈現長期的憂鬱症狀，持續至少兩年，其中超過一半的天數，幾乎一整天都感到憂鬱。
- 當個案感覺憂鬱時，出現至少兩項相關症狀，包括：(1)吃不下或吃得太多；(2)失眠或嗜睡；(3)疲倦或沒有力氣；(4)感到自卑；(5)注意力不集中或難以做決定；(6)覺得未來沒有希望。在這兩年中，從來沒有連續兩個月完全沒有症狀。個案因這些症狀而感到顯著痛苦，或是因此在社交、職業或其他重要領域的功能顯著下降。

DSM-5持續性憂鬱症 (II)

- 診斷需排除因服用藥物、濫用物質或身體疾病造成憂鬱症狀；同時，這些憂鬱症狀也不能用妄想症、思覺失調症（包括相關類群診斷）或其他精神病症作更好的解釋。
- 個案需不曾有過躁症或輕躁症發作，也不曾符合循環性情緒障礙症的診斷準則。另外，若憂鬱症狀的嚴重程度達到重鬱症的標準，並且持續長達連續兩年的時間，這也歸類為「持續性憂鬱症」。

DSM-5 適應障礙症(I)

- 「適應障礙症」指的就是壓力反應。
- 個案在遭遇壓力源後的三個月內出現情緒或行為症狀，其影響所及包括：
  (1)引發超乎預期應有的反應，並造成顯著痛苦；或
  (2)導致個案社交、職業或其他重要領域的功能顯著下降；又或者是(1)(2)兩者兼具。
- 一旦壓力源消失，或該壓力事件的後果不復存在後，症狀應在六個月內消失。

DSM-5 適應障礙症(II)

- 依據個案的情緒、行為症狀，可進一步分類註記為：合併憂鬱情緒、合併焦慮情緒、合併混合焦慮及憂鬱情緒等。
- 這些因壓力造成的困擾，並不符合其他精神疾病的診斷標準，也不僅只是原有精神疾病的症狀惡化；同時，如果個案正處於正常哀傷反應時，則不可歸類為適應障礙症。

憂鬱症與其他精神病的鑑別診斷1

- 要確認對病人重度憂鬱障礙的診斷最為恰當，必須排除其他可能的診斷，包括情緒低落障礙、環境適應性障礙合併憂鬱情緒或雙向情感障礙。
- 情緒低落障礙是一種慢性的、相對較輕的心境紊亂，病人在至少兩年的時間段內幾乎每天都情緒低落。
- 情緒低落障礙的徵狀沒有重度憂鬱障礙嚴重，但是情緒低落障礙病人更易受到疊加的重度憂鬱發作的困擾（有時被稱為**雙重憂鬱症**)。

憂鬱症與其他精神病的鑑別診斷2

- 環境適應性障礙合併憂鬱情緒是由一種特定的事件或應激產生的心理反應所引起的心境紊亂。適應性障礙的情緒和行為上的徵狀雖然明顯但是不符合重度憂鬱發作的標準。
- 雙向情感障礙，之前被稱之為躁鬱症，這種病的特點是憂鬱期和躁狂期或輕躁期輪流交替。
- 有關於憂鬱症是否應該被單獨歸為一類的爭論，因為被確診為重型憂鬱障礙的病患也經常會體驗到輕躁徵狀，提示各種情緒低落障礙應當是一個連續體。

憂鬱症與其他精神病共病現象1

❖一、憂鬱症常見的**共患精神疾病**：

1. 恐慌症：50-65%患者合併有憂鬱症。
2. 強迫症：67%患者合併有憂鬱症。
3. 重大創傷後症候群：48%患者合併有憂鬱症。
4. 焦慮症：8-39%患者合併有憂鬱症。
5. 其他如精神分裂症、畏懼症，也都有很高的比例合併有憂鬱症。

憂鬱症與其他精神病共病現象2

❖二、憂鬱症常見的**共患身體疾病**：

1. 巴金森症：研究顯示，憂鬱症會讓巴金森症患者的認知功能逐漸惡化，而巴金森症本身的腦部單胺酸功能改變，加上患者的失能，造成憂鬱症比例增高。

2. 心肌梗塞：罹患心肌梗塞後的半年追蹤研究顯示，合併憂鬱症患者的死亡率是沒有合併憂鬱症患者的4 倍，原因和憂鬱症患者脂肪代謝的改變、交感神經活動增加、及抗憂鬱劑的使用有關。

憂鬱症與其他精神病共病現象3

❖二、憂鬱症常見的**共患身體疾病**：

3.糖尿病：一項追蹤憂鬱症患者13年的研究顯示，憂鬱症患者罹患糖尿病的比例是正常人的2.2倍，原因除憂鬱症患者內分泌的改變外，飲食異常及運動的減少也是原因之一。

4.其他如中風、停經後徵候群、痴呆症等身體疾病，也常見合併有憂鬱症。

❖以上與憂鬱症共患的身體疾病，臨床上容易被輕忽，造成疾病本身的惡化或預後變差。

輕中重度憂鬱症的治療1

- 輕度憂鬱可以調整壓力、自我調適。
- 中、重度以上憂鬱症則建議先以藥物治療為主，搭配非藥物的支持性心理治療，效果最佳。過早放棄治療、治療不完全，常是憂鬱症容易復發的原因。
- **憂鬱症的治療**主要分為三個部分:

一、心理治療:主要是支持性、認知改變為取向的心理治療。支持性心理治療，支持憂鬱患者的自我強度，給予鼓勵、肯定、說明、傾聽、同理與再保證。認知心理治療，則在於教導患者辨識並改變不合理的錯誤認知，發展新的思考模式。

輕中重度憂鬱症的治療2

❖ 憂鬱症的治療主要分為三個部分:

二、藥物治療和電痙攣治療(ECT): 藥物治療是近50年發展最快的部分，依作用機轉可分成以下五類：

1. 三環抗憂鬱劑(tricyclic antidepressants, TCA)
2. 單胺氧化酶抑制劑(monoamine oxidase inhibitors, MAOI)
3. 選擇性血清素回收抑制劑(selective serotonin reuptake inhibitors, SSRI)
4. 血清素及正腎上腺素回收抑制劑(serotonin and norepinephrine reuptake inhibitors, SNRI)
5. NaSSA(noradrenergic and specific serotonergic antidepressants)

輕中重度憂鬱症的治療3

❖ 憂鬱症的治療主要分為三個部分:

二、藥物治療和電痙攣治療(ECT):

新一代的抗憂鬱藥物，可以改善大腦血清素、或是正腎上腺素的調節分泌，如：千憂解(Cymbalta)、百憂解(Prozac)、克憂果(Seroxat)、無鬱寧(Luvox)、樂復得(Zoloft)、速悅(Efexor)、威博雋(Wellbutrin)、歐蕾思(Aurorix)、美思鬱(Cirzodone)、鬱思樂(Ixel)、立普能(Lexapro)、樂活憂(Remeron)等等，副作用很少，效果在1-2週心情就開始改善，3-4週情緒就幾乎回到水平。電痙攣治療(ECT)目前已較少使用。

輕中重度憂鬱症的治療4

❖ 憂鬱症的治療主要分為三個部分:

三、良好的生活習慣: 包括規律生活，養成固定的運動習慣，戒除喝酒、抽煙等不良嗜好，培養可以放鬆自己的方法，參加社區或社團活動，增加人際關係網絡，皆可有效改善憂鬱症。

❖ 藥物的使用原則如下：

1.選擇副作用較少，病人可以忍受的藥物，因為無論使用哪一種藥物，對於療效差異皆不大。

2.儘可能使用單一種的抗憂鬱劑，除有特別原因，例如雙極性情感疾病，在憂鬱期時，可以使用抗憂鬱劑加上鋰鹽治療。

輕中重度憂鬱症的治療5

❖ 藥物的使用原則如下：

1. 盡量使用每日服用一次的藥物增加病人服藥遵從性。
2. 可以優先選擇病人或其家屬過去曾服用過且有效的抗憂鬱劑。
3. 對於激躁不安的憂鬱症患者，TCA或SARI有鎮靜作用；反之，反應變遲滯的憂鬱症患者，可以使用較具活力的，如MAOI、SNRI。
4. 憂鬱症患者有精神病症狀者，可以合併低劑量的抗精神病藥物。

自殺預防及強制住院相關法令與通報1

- 自殺不算犯罪，但防治自殺是國家的責任，自殺防治專線:0800-788-955。
- 憲法第 15 條：人民之生存權、工作權及財產權，應予保障。
- 警察職權行使法第 19 條有下情形之一者得為管束：

一、瘋狂或酒醉，非管束不能救護其生命、身體之危險，或預防他人生命、身體之危險。

二、意圖自殺，非管束不能救護其生命。

三、暴行或鬥毆，非管束不能預防其傷害。

自殺預防及強制住院相關法令與通報2

- 警察職權行使法第 19 條有下列情形之一者得為管束：

四、其他認為必須救護或有危害公共安全之虞，非管束不能救護或不能預防危害。

警察為前項管束，應於危險或危害結束時終止管束，管束時間最長不得逾二十四小時；並應即時以適當方法通知或交由其家屬或其他關係人，或適當之機關 (構) 或人員保護。

- 警察職權行使法第 20 條有下列情形之一者，於必要時，得對其使用警銬或其他經核定之戒具：

一、抗拒留置、管束措施時。

二、攻擊警察或他人，毀損執行人員或他人物品或有攻擊、毀損行為之虞時。

三、自殺、自傷或有自殺、自傷之虞時。

自殺預防及強制住院相關法令與通報3

- **精神衛生法**（中華民國九十六年七月四日修正公布全文 63 條；並自公布後一年施行）
- 第二十一條 (960605全文修正)

  嚴重病人如有明顯傷害他人或自己之虞，或有傷害行為時，經專科醫師診斷有全日住院治療之必要者，保護人應協助病人，前往精神醫療機構辦理住院。前項嚴重病人不接受全日住院治療時，應由二位以上專科醫師鑑定，經書面證明有全日住院治療之必要者，應強制其住院；其強制住院，應在中央衛生主管機關指定之精神醫療機構為之。

  前項鑑定，以全日住院方式為之者，其住院鑑定期間，以七日為限。

自殺預防及強制住院相關法令與通報4

- 第二十三條 (960605全文修正)
  依第二十一條第二項規定之強制住院，其期間以三十日為限。但經二位專科醫師鑑定，認有必要繼續住院治療者，應留院治療。嚴重病人不接受時，應強制其繼續住院，並通知其保護人或家屬及當地衛生主管機關。強制住院期間，每隔六個月，應依上述程序重新評估。

自殺預防及強制住院相關法令與通報5

- 精神照護機構為保護病人安全，經告知病人後，得限制其活動之區域範圍。
- 精神醫療機構為醫療之目的或為防範緊急暴力意外、自殺或自傷之事件，得拘束病人身體或限制其行動自由於特定之保護設施內，並應定時評估，不得逾必要之時間。
- 精神醫療機構以外之精神照護機構，為防範緊急暴力意外、自殺或自傷之事件，得拘束病人身體，並立即護送其就醫。

附錄二、常用諮商微技巧

常用諮商微技巧–I

- **Minimal verbal response: 肢體語言及口語之應用**

  用來表現你正用心在傾聽對方亦可鼓勵對方繼續談話，這技巧通常配合使用肢體語言，如點頭和微笑：

  - 嗯嗯…
  - 我了解
  - 是..是…

- **Unstructured invitations: 非結構性的邀約**

  通常使用在初期建立關係時。此技巧可以提供個案自行選擇主題及方向來討論：

  - please begin wherever you would like（請就你想談的開始談吧；想說什麼就說什麼吧!）
  - 想談些什麼呢？

常用諮商微技巧-II

- **Silence: 靜默**
  Speaker: I am not sure how to begin.
  Responder: Umm-hum （with a reassuring smile）
  Speaker: 我想這次我真的是搞砸了
  Responder: 身體微向前屈並帶著想繼續聽下去的表情
- **Closed questions: 封閉性問題**
  尋求『是』或『否』的答案時使用
  - 你很怕他嗎?
  - 你昨天晚上有去嗎?
  - 你幾歲?

常用諮商微技巧-III

- **Probes: 探索**

  可以告訴我你對他的感覺嗎?
  - 你覺得你可以如何達成你的目標呢？
  - 可以請你描述所有你所記得的情境嗎?
- **Requests for clarification: 要求澄清**

  應用在個案似乎很混淆或者未覺察到自己前後矛盾的語言表達時
  - I am a little confused. Please help me by explaining more clearly why you want to quit college.
  - Please help me to understand how you believe that her behavior made you so angry.

常用諮商微技巧-IV

- **Accents: 語調重複**

  用在強調某個重點或者需要個案加強說明的點或者是感覺到必須進一步探討的議題時：

  - **Speaker:** 上星期我去了一個很棒的舞會，但是我也不知道爲什麼我會感覺到好骯髒、好討厭？

    Responder: 骯髒？討厭？

    Speaker: 這些聚會最大的缺點就是必須要試著去討好那些我根本就不在乎的人

    Responder: 試著去討好不在乎的人？

常用諮商微技巧-V

- **Restatements:重覆語意**

  重述個案談話內容的某一部份，通常是一個句子或者是某個鮮明的重點：
  - **Speaker:** 數學真的很難！

    Responder: 數學真的很難！
  - **Speaker:** 我真的不想變懶惰！
  - **Responder:** 你真的不想變懶惰！
- **Reflections of feeling: 情緒之反應**

  回映（mirroring）個案的情緒及心理感受如：悲傷、害怕：
  - **Speaker:** 我真的很害怕未來！

    Responder: 你真的很害怕未來！
  - **Speaker:** 你知道嗎？所有的事都不對勁了，我甚至想不起來有什麼可以令我感到快樂？

    Responder: 聽起來你似乎是憂鬱的。

常用諮商微技巧-VI

- **Summarizations of feelings, thoughts or behaviors: 感覺,想法, 或行為之總結**

  Speaker: sometimes I love my folks, but I also hate them.

  Responder: you both love and hate your parents.

  Speaker: If I could be successful and liked.

  Responder: you seem to believe both that you must be perfect and loved by everyone.

- **Reflections of thinking-believing: 回映價值觀及相關想法**

  Speaker: I really don’t like management, but might like computer science.

  Responder: so you think you might like to major in computer science.

常用諮商微技巧-VII

- **Confrontations: 面質**

  Speaker: 我根本不在乎我媽要我做什麼，我喜歡我交往的對象，而且我和喬治相處的很好。但是我還是得努力爭取我媽對喬治的認同，雖然他對我而言是有一點太老了。

  Responder : 雖然你說不在乎你媽要你做什麼，但是你仍期待他能認同喬治。

- **Acknowledgements of (reflection of) behavior:提醒(回映)行為表現**

  Speaker: 談話時緊握拳頭

  Responder :當你提到學校的時候，你是緊握拳頭的。

- **Focusing commands: 焦點性建議**

  Speaker: 談話時緊握拳頭

  Responder : 注意一下你的手在做什麼?

常用諮商微技巧-VII

- **Requests-suggestions for speaker activity**

  Responder:描述一下你是如何看待你未來的規劃的

  Responder: 用五分鐘的時間談談你的優點，但不可以使用『是…可是. . 』等字詞

- **Rational exaggerations: 合理的誇大**

  Speaker: 我就是沒有辦法在團體中說話，因為我總是覺得自己很呆而且很不合時宜，我就是會擔心可能會有人認為我好笨，然後就排斥我，如果我說錯了什麼的話。

  Responder: 你似乎相信你必須被每個人所認同，而且如果有人不被你所說的話吸引，你就會覺得這是很恐怖或者不能接受的事。

常用諮商微技巧-VIII

- **Interpretations: 解析**

  Speaker: 他總是不幫忙作家裡的事，我就覺得很生氣。

  Responder: 聽起來似乎你是認為， 他 不幫忙作家裡的事是因為他不夠愛你，而不是他可能是偷懶或有其他原因才不做家事。
- Information giving:

行為科學

與青少年憂鬱症之診斷與治療

陳怡如[1]　陳志道[2]　林育如[3]

前言

根據國外的研究報告指出，小於13歲的兒童憂鬱症(depression)盛行率預估為2.8%，13~18歲的青少年則是5.6%[1]。兒童與青少年憂鬱症的發生被高度關注，因為其帶來嚴重和持續性的影響；罹患過憂鬱症的青少年大約有60%在成年時期復發，而且有青少年憂鬱史的成年人比起沒有憂鬱史者，有更高的自殺率[2]。青少年的憂鬱症和虐待、被忽視、學習成績差、物質濫用和過早懷孕有關，並且會進一步影響到成年期的工作和家庭[3-5]。雖然青少年憂鬱症的盛行率很高，但卻被嚴重地疏忽而使他們沒能接受正確的治療。

危險因子

雖然兒童青少年憂鬱症的危險因子可被分為生物性、心理性和環境性(表一)，但通常這些因子都是相互關聯的[6-9]；例如病患父母親的憂鬱症和兒童青少年憂鬱症的發生是高度相關的，父母親有憂鬱症的兒童將來發生憂鬱症的機率是沒有的三倍[10]；危險因子產生的年齡可預測未來憂鬱症發生的可能性，如三到五歲有內科疾病，像是糖尿病或氣喘的兒童，未來可能會有重鬱症發作(major depressive episode)；還有被老師視為有敵意的5歲兒童，將來有憂鬱症的風險也較高[9]。

1 亞東紀念醫院 家庭醫學科 住院醫師
2 亞東紀念醫院 家庭醫學科 主任
3 亞東紀念醫院 精神科 主治醫師
關鍵詞：depression, child, adolescent, diagnosis, treatment
通訊作者：陳志道

篩檢

根據U.S. Preventive Services Task Force的建議，篩檢12~18歲的青少年可早期偵測並治療憂鬱症[11]；但目前還沒有足夠的證據顯示兒童進行例行性篩檢是有幫助的，所以如果能是針對至少有一個危險因子的兒童做篩檢，應該會比例行性篩檢來的有幫助。篩檢工具可以提示症狀的嚴重度，包括適用8~16歲的台灣版兒童青少年憂鬱量表(Children's Depression Inventory_Taiwan Version)[12]和13歲以上的貝克憂鬱量表第二版中文版[23]，兩者都是讓個案自填的。台灣版兒童青少年憂鬱量表是一套全球使用率最高的兒童青少年憂鬱量表，共有五個分量表，共27題，和一個整體特質的表現，內容分別為：

表一 兒童與青少年憂鬱症的危險因子

生物性	心理性	環境
憂鬱症的家族史	情感依賴	反社會的同儕
女性	自殺未遂史	身體活動減少
青春期的荷爾蒙改變	無效的應對技巧	與父母的衝突增加
低出生體重	自卑	關係的喪失（如家庭成員或朋友的死亡、男女關係、友誼）
母親年齡小於18歲	負面的身體形象	低社經地位
內科疾病（如氣喘、糖尿病、偏頭痛）	負面的思維方式（如壞事總是發生在我身上，沒有事情是照著計畫走的）	暴飲暴食
肥胖	自我意識	學習成績差
其它精神科疾病（如焦慮症、學習障礙）		交友關係不佳
睡眠中斷		物質濫用
		創傷事件（如身體或性虐待、事故）

資料來源：參考資料6-9

表二 兒童、青少年以及成人的重鬱疾患(major depression disorder)診斷準則

以下五項(或更多)在兩週中同時出現，造成先前功能改變；至少包含以下症狀之一(1)憂鬱情緒或(2)失去興趣或愉悅感。
幾乎整天且每天心情憂鬱，可由主觀報告(如感到悲傷、空虛或無助)或由他人觀察(如看起來在哭)得知。(註：孩童與青少年可以是情緒易怒)
幾乎整天且每天對所有活動降低興趣或愉悅感(主觀說明或他人觀察)。
體重明顯減輕或增加(一個月內體重變化超過5%)，或幾乎每天食慾降低或增加。(註：在孩童，需考量無法達到預期體重。)
幾乎每天都失眠或嗜眠。
幾乎每天精神動作激動或遲緩(別人觀察到，不只是主觀感受不安或緩慢)。
幾乎每天疲倦或無精打采。
幾乎每天自我感到無價值感，或者有過度或不恰當的罪惡感(可能達妄想的程度；不僅是對生病自責或內責)。
幾乎每天思考能力和專注力降低，或是猶豫不決(主觀報告或他人觀察)。
反覆想到死亡(不只是害怕死亡)，反覆有自殺意念而無具體計畫，或有自殺舉動，或是有具體的自殺計畫。
這些症狀引起臨床上顯著苦惱或社交、職業或其他重要領域功能減損。
這些症狀無法歸因於某一物質或另一身體病況的生理效應。
鬱症發作無法以情感性思覺失調症、思覺失調症、類思覺失調症、妄想症或其他特定或非特定思覺失調症和其他精神病症做更好的解釋。
從未有過躁症或輕躁症發作。

資料來源：參考資料14

1.負向情緒 2.效率低落 3.負向自尊 4.人際問題 5.失去興趣，最後會得到一個T分數；在一般有行為問題的學童，通常將T分數65分以上視為達臨床顯著水準；在沒有明確行為問題的學童，則以70分或75分以上視為可能有臨床問題[13]。貝克憂鬱量表第二版包含21個問題，每個問題0~3分，假若個人長期維持在17分以上則建議尋求專業人員協助治療[23]。篩檢工具的選擇必須考量到病人的年齡、閱讀程度以及完成測驗所需的時間。

臨床症狀與診斷

雖然憂鬱症的診斷準則不管是兒童、青少年或成人都一樣(表三)[14]，但是症狀會以不同的方式來表現。青少年傾向以乏樂感、無聊、無助、嗜睡、體重變化(包括未能達到適當的體重)、酒精或毒品的使用和企圖自殺來表現；兒童則比較會有身體症狀(somatic symptoms)、煩躁、分離焦慮症(separation anxiety)、恐懼症和幻覺[15]。另一方面還需考量兒童的心智程度，因為較小的兒童可能不會用語言來表達悲傷。自述的症狀和父母敘述的也有所出入，父母比較會觀察到外顯的症狀(如易怒)，而小孩則較會表達內在的情緒(如憂鬱)[7]。

診斷鬱症時，須先排除和憂鬱情緒有關的內科疾病，例如甲狀腺功能亢進或低下、貧血、使用特定的藥物(包括isotretinoin)(表四)[7]。有些精神疾病的表現也和憂鬱症類似，尤其是適應障礙、輕鬱症和躁鬱症。適應障礙的特徵是病人的心理反應起因於某種〝特定的壓力源〞，在壓力產生後三個月內開始有症狀，並且造成顯著的影響，適應障礙併發憂鬱情緒(adjustment disorder with depressive features)可能被誤診為鬱症，因為兩者的表現都包括憂鬱、悲傷和無望感，差別在於適應障礙和特定事件有關，且症狀並未符合鬱症的診斷準則。兒童與青少年輕鬱症的特徵是持續一年的憂鬱心情，和鬱症相比，病程較長但症狀較輕，憂鬱症狀在兒童與青少年會以煩躁不安來表現，病人也常常會有低自尊和社交技巧不佳。躁鬱

表三　憂鬱症的鑑別診斷

內科疾病	貧血、癌症、慢性疲勞症候群(chronic fatigue syndrome)、甲狀腺功能亢進或低下、傳染性病因(如HIV、肝炎)、發炎性腸道疾病(inflammatory bowel disease)、單核球增多症(mononucleosis)、中樞神經系統疾病、紅斑性狼瘡或膠原血管疾病(collagen vascular disease)
藥物使用	抗精神病藥物(antipsychotics)、beta blockers、避孕藥、類固醇、isotretinoin
精神疾病	適應障礙併發憂鬱情緒(adjustment disorder with depressive features)、厭食症(anorexia nervosa)、焦慮症(anxiety disorders)、注意力不足過動症(ADHD)、躁鬱症(bipolar disorder)、暴食症(bulimia nervosa、行為規範障礙(conduct disorder)、輕鬱症(dysthymia)、人格障礙(personality disorders)、精神病(psychotic disorders)、物質使用(如酒精、barbiturates、海洛因)

資料來源：參考資料7

表四 兒童與青少年憂鬱症指引—使用藥物治療的問題

是中度到重度的憂鬱症嗎？
以前有憂鬱症發作過嗎？
以前是否曾使用藥物來治療憂鬱症？
有憂鬱症的家族史嗎？
有對藥物有顯著反應的憂鬱症家族史嗎？
環境因素的壓力源已被解除，但情緒卻沒有相對應的進步？
已嘗試過實證的心理治療(如認知行為治療、人際關係治療)，但卻沒有成功？

註：針對以上的問題，任何一題病人的答案是〝是〞，則考慮開始藥物治療。
資料來源：參考資料19,22

症包含了鬱症和交替出現的躁症(mania)和輕躁症(hypomania)，在這期間會有加重的煩躁不安、活力增加、行為誇大和跳躍性的思考，在診斷憂鬱症時須先排除躁鬱症，因為抗憂鬱藥物可引發躁狂症狀。

自殺風險的評估

根據美國Centers for Disease Control and Prevention的統計，2007年10~14歲的兒童自殺率大約是每十萬人有0.9位，15~19歲的青少年則是每十萬人有6.9位。自殺的方法包括槍支、窒息和中毒，兒童比較常使用窒息的方法，而青少年則比較會利用槍支。所以會建議對憂鬱症的兒童與青少年做例行性的自殺評估，尤其是在服用抗憂鬱劑的病人[16]。

如果病人有自殺的想法，進一步評估須包括自殺意念的頻率、是否有特定的自殺計畫、計畫的可行性、是否有保護性因子(如社會支持)以及其他相關的因素(如物質使用或自殺史)。如果確定病人有自殘的風險，緊急轉給精神科醫師或急診是必須的。對於自傷風險較低的病人，可以讓父母或照顧者給予密切的觀察，移除所有會被拿來自殘的物品，增加回診的頻率，並且教育他們如何尋求協助(如急診、自殺專線)。另外也需教育父母親和家庭成員，如出現以下情形須立刻回診：自殺意念增加、衝動、易怒、躁動和煩躁不安增加，或言語迫促(pressured speech)[17]。

治療

兒童與青少年憂鬱症的治療包括心理治療、藥物治療和兩者的合併治療。治療的選擇必須考慮疾病的嚴重度、病人的喜好、病人發展的程度、相關的危險因子和治療的可行性[7]；也須提供病人和家屬治療的風險和好處、治療的期望，另外還須持續的追蹤。

1. 心理治療

根據American Psychiatric Association和 American Academy of Child and Adolescent Psychiatry的建議，心理治療對於兒童與青少年憂鬱症是不可或缺的，他們建議，對於輕微的憂鬱症使用心理治療，而中度到重度的憂鬱症，則合併心理和藥物治療。認知行為治療(cognitive behavior therapy, CBT)和人際關係治療(interpersonal therapy)已被證實對青少年憂鬱症有效，而CBT也被證實對兒童憂鬱症有效。CBT可以增進應對技巧，改善溝通技巧和同濟的關係，幫助解決困難，戰勝負面的思考模式，以及增進情緒的掌控；不一樣的是，人際關係治療強調適應關係的變化，轉換個人的角色，幫助形成人際關係[7]。CBT合併藥物的治療已被證實在達到憂鬱症的緩解上，比單獨使用藥物來的有效[18]。

2. 藥物治療

何時考慮加上抗憂鬱藥物，須參考憂鬱症的嚴重程度和病史(表五)[19, 22]。抗憂鬱藥物的使用不適合直接從成人的研究數據推斷到兒童與青少年，因為後者的神經系統可能還沒發育完全。guideline建議對於兒童與青少年中度到重度的憂鬱症，使用fluoxetine、citalopram和sertraline做為第一線的治療[20]。另外escitalopram已被許可用於12歲以上的憂鬱症青少年。藥物應從最低的有效劑量開始給予，之後再根據病人的反應和副作用來調整；如果一開始的第一線藥物沒有效，應考慮更換成其他第一線藥物。所有抗憂鬱藥都有黑框警示(black box warning)自殺風險的增加，所以建議要密集地追蹤病人(例如每週一次電話追蹤、第一個月治療安排規律的回診)來評估自殺的風險和藥物副作用，像是腸胃道症狀、緊張、頭痛和躁動[20]。如果在嘗試過所有第一線藥物之後，病情沒有顯著的進步或沒有緩解，則強烈建議轉診到精神科做進一步的評估。

療程和轉診時機

兒童與青少年憂鬱症的療程，須持續到疾病緩解後的4~6個月[21]；至於確切的治療時間，則須根據之前復發的病史以及目前心理社會的壓力情形來決定。如果病人是小於十一歲的兒童、有慢性憂鬱症、合併物質使用、有其他精神疾病、有計畫性的自殺或在治療過程缺乏父母親的參與，都建議轉診給精神科醫師。

參考資料

1. Costello EJ, Erkanli A, Angold A: Is there an epidemic of child or adolescent depression? J Child Psychol Psychiatry. 2006;47:1263-71.
2. Weissman MM, Wolk S, Goldstein RB, et al: Depressed adolescents grown up. JAMA. 1999;281:1707-13.
3. Fergusson DM, Woodward LJ: Mental health, educational, and social role outcomes of adolescents with depression. Arch Gen Psychiatry. 2002; 59:225-31.
4. Keenan-Miller D, Hammen CL, Brennan PA: Health outcomes related to early adolescent

depression. J Adolesc Health. 2007;41:256-62.
5. Wells KB, Kataoka SH, Asarnow JR: Affective disorders in children and adolescents: addressing unmet need in primary care settings. Biol Psychiatry. 2001;49:1111-20.
6. Kessler RC, Avenevoli S, Ries Merikangas K: Mood disorders in children and adolescents: an epidemiologic perspective. Biol Psychiatry. 2001; 49:1002-14.
7. Richardson LP, Katzenellenbogen R: Childhood and adolescent depression: the role of primary care providers in diagnosis and treatment. Curr Probl Pediatr Adolesc Health Care. 2005;35:6-24.
8. Brent DA, Maalouf FT: Pediatric depression: is there evidence to improve evidence-based treatments? J Child Psychol Psychiatry. 2009; 50:143-52.
9. Beardslee WR, Gladstone TR: Prevention of childhood depression: recent findings and future prospects. Biol Psychiatry. 2001;49:1101-10.
10. Birmaher B, Ryan ND, Williamson DE et al: Childhood and adolescent depression: a review of the past 10 years. Part I. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 1996;35:1427-39.
11. U.S. Preventive Services Task Force: Screening and treatment for major depressive disorder in children and adolescents: recommendation statement. Pediatrics. 2009;123:1223-8.
12. Kovacs M, MHS Staff 編製；陳淑惠修訂：台灣版兒童青少年憂鬱量表。新北市：心理出版社股份有限公司。
13. Kovacs M, MHS Staff 編製；陳淑惠修訂：台灣版兒童青少年憂鬱量表指導手冊。新北市：心理出版社股份有限公司，2008：21。
14. American Psychiatric Association 台灣精神醫學會翻譯：DSM-5精神疾病診斷準則手冊。新北市：合記圖書出版社，2014：94-5。
15. Williams SB, O' Connor EA, Eder M, Whitlock EP: Screening for child and adolescent depression in primary care settings: a systematic evidence review for the US Preventive Services Task Force. Pediatrics. 2009;123:e716-e35.
16. Horowitz LM, Ballard ED, Pao M: Suicide screening in schools, primary care and emergency departments. Curr Opin Pediatr. 2009;21:620-7.
17. Shain BN, American Academy of Pediatrics Committee on Adolescence: Suicide and suicide attempts in adolescents. Pediatrics. 2007;120: 669-76.
18. Brent D, Emslie G, Clarke G, et al: Switching to another SSRI or to venlafaxine with or without cognitive behavioral therapy for adolescents with SSRI-resistant depression: the TORDIA randomized controlled trial. JAMA. 2008;299:901-13.
19. Ryan ND: Child and adolescent depression: short-term treatment effectiveness and long-term opportunities. Int J Methods Psychiatr Res. 2003; 12:44-53.
20. Hughes CW, Emslie GJ, Crismon ML, et al: Texas Children' s Medication Algorithm Project: update from Texas Consensus Conference Panel on Medication Treatment of Childhood Major Depressive Disorder. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2007;46:667-86.
21. Emslie GJ, Mayes TL: Mood disorders in children and adolescents: psychopharmacological treatment. Biol Psychiatry. 2001;49:1082-90.
22. Emslie GJ, Mayes TL, Ruberu M: Continuation and maintenance therapy of early-onset major depressive disorder. Paediatr Drugs. 2005; 7:203-17.
23. Beck AT, Steer RA, Brown GK, 陳心怡翻譯：貝克憂鬱量表第二版中文版。台北市：中國行為科學社股份有限公司，1900：15-26。